

RADIOLOGIE — IMAGERIE MÉDICALE

Fiches QE Haute Fréquence — Version 1

Cross-match : 700 QEs officielles (2018 → janvier 2026 (14 sessions)) × Cours AIO Radiologie (2163 p.) + 700 QE officielles e-qe.online

FMPM — Concours de Radiologie 2026 • Cross-match QE officielles × cours officiel

PARTIE 1 — CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 700 QEs (14 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	L'exploration radiologique du thorax	45 Q	—
2	Approche diagnostique d'une lésion osseuse	44 Q	—
3	Traumatismes crânio-encéphaliques	41 Q	—
4	Imagerie du foie	39 Q	—
5	Le médiastin normal et pathologique	38 Q	—
6	Imagerie pédiatrique	36 Q	—
7	Moyens d'exploration en neuroradiologie	35 Q	—
8	Exploration radiologique du pelvis féminin	34 Q	—
9	Imagerie des cancers broncho-pulmonaires	31 Q	—
10	Les tumeurs osseuses malignes	29 Q	—
11	Syndrome alvéolaire et interstitiel	28 Q	—
12	Exploration radiologique de l'appareil urinaire	25 Q	—
13	Les tumeurs osseuses bénignes	24 Q	—
14	Exploration radiologique du sein	22 Q	—
15	Abdomen aigu	22 Q	—
16	Imagerie des voies biliaires	21 Q	—
17	Syndrome obstructif des voies urinaires	19 Q	—
18	Imagerie des AVC	18 Q	—
19	Imagerie des infections pulmonaires	18 Q	—
20	Imagerie du tube digestif	18 Q	—
21	Exploration radiologique du rachis	17 Q	—
22	Exploration d'une masse pelvienne	16 Q	—
23	Ostéo-arthrites — ostéomyélite	14 Q	—
24	Syndrome bronchique / atélectasie	14 Q	—
25	Syndrome de masse rénale	12 Q	—
26	Imagerie du pancréas	11 Q	—
27	Radiologie interventionnelle	9 Q	—

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
28	Exploration du nodule du sein	9 Q	—
29	Syndrome pleural	8 Q	—
30	Les spondylodiscites	2 Q	—

PARTIE 2 — MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 14 sessions, chaque examen ~50 questions.

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'exam
L'exploration radiologique du thorax	45	3.21	6.4%
Approche diagnostique d'une lésion osseuse	44	3.14	6.3%
Traumatismes crânio-encéphaliques	41	2.93	5.9%
Imagerie du foie	39	2.79	5.6%
Le médiastin normal et pathologique	38	2.71	5.4%
Imagerie pédiatrique	36	2.57	5.1%
Moyens d'exploration en neuroradiologie	35	2.50	5.0%
Exploration radiologique du pelvis féminin	34	2.43	4.9%
Imagerie des cancers broncho-pulmonaires	31	2.21	4.4%
Les tumeurs osseuses malignes	29	2.07	4.1%
Syndrome alvéolaire et interstitiel	28	2.00	4.0%
Exploration radiologique de l'appareil urinaire	25	1.79	3.6%
Les tumeurs osseuses bénignes	24	1.71	3.4%
Exploration radiologique du sein	22	1.57	3.1%
Abdomen aigu	22	1.57	3.1%
Imagerie des voies biliaires	21	1.50	3.0%
Syndrome obstructif des voies urinaires	19	1.36	2.7%
Imagerie des AVC	18	1.29	2.6%
Imagerie des infections pulmonaires	18	1.29	2.6%
Imagerie du tube digestif	18	1.29	2.6%
Exploration radiologique du rachis	17	1.21	2.4%
Exploration d'une masse pelvienne	16	1.14	2.3%
Ostéo-arthrites — ostéomyélite	14	1.00	2.0%
Syndrome bronchique / atélectasie	14	1.00	2.0%
Syndrome de masse rénale	12	0.86	1.7%
Imagerie du pancréas	11	0.79	1.6%
Radiologie interventionnelle	9	0.64	1.3%
Exploration du nodule du sein	9	0.64	1.3%
Syndrome pleural	8	0.57	1.1%
Les spondylodiscites	2	0.14	0.3%
TOTAL leçons officielles classées (hors 1 Q inclassifiable)	699 Q	49.9	99.9%

PARTIE 3 — QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (Δ) / source (□) / lien cours (□) / citations (□)

[RANG 1] L'EXPLORATION RADIOLOGIQUE DU THORAX

— • ~3.21 Q/examen — 45 Q (6.4%)

Critères de réussite d'une radiographie thoracique DE FACE :

- Incidence postéro-antérieure (PA), patient DEBOUT, en inspiration profonde/forcée
- Omoplates dégagées (projetées EN DEHORS des champs pulmonaires)
- Extrémités internes des clavicules équidistantes de la ligne des épineuses (pas de rotation)
- Poche à air gastrique visible en sous-diaphragmatique GAUCHE
- Corps vertébraux visibles en rétrocardiaque = bonne pénétration ; 6e arc costal antérieur droit au-dessus de la coupole
- Δ Incidence antéro-postérieure (AP) → cliché de mauvaise qualité / patient alité
- Δ Omoplates se projetant SUR les poumons = mauvais dégagement
- Δ Corps vertébraux INVISIBLES en rétrocardiaque = sous-pénétration
- Δ Cliché systématique de profil chez la femme enceinte au 1er trimestre = FAUX

□ Vu : 26J, 24N Q20, 23N Q26, 22N Q26, 21N Q8, 21R Q20, 20N Q10-11, 19N Q2, 18N Q2 (≥9×)

Radiographie thoracique DE PROFIL — que permet-elle ?

- Explore les régions RÉTRO-STERNALE et RÉTRO-CARDIAQUE
- Visualise les SCISSURES et les culs-de-sac costo-diaphragmatiques postérieurs
- Localise le siège antérieur ou postérieur d'une opacité ; situe un lobe
- Δ N'est PAS de réalisation systématique
- Δ Ne sert pas à explorer les HILES pulmonaires
- Δ Ne complète pas systématiquement un cliché de face en inspiration forcée

□ Vu : 26J Q25, 21R Q21, 20N Q12, 19R Q24, 18N Q8 (≥5×)

Cliché en DÉCUBITUS LATÉRAL à rayon horizontal / clichés dynamiques :

- Indiqué pour une pleurésie de FAIBLE abondance et un pneumothorax minime
- Étude de la mobilité des coupoles diaphragmatiques (inspiration/expiration)
- Diagnostic d'une pleurésie de faible abondance chez le patient de réanimation
- Δ Ne fait pas le diagnostic étiologique d'une opacité alvéolaire ni d'un infiltrat interstitiel
- Δ Ne diagnostique pas les dilatations de bronches

□ Vu : 26J Q26-27, 25J Q27, 24R Q14, 20N Q10, 20R Q1-2 (≥6×)

Lignes médiastinales visibles sur le cliché DE FACE :

- Ligne para-trachéale droite
- Ligne para-vertébrale gauche
- Ligne para-œsophagienne
- Ligne para-aortique gauche
- Δ Ligne para-azygos GAUCHE = FAUX (l'arc azygo-œsophagien est à droite)
- Δ Ligne para-aortique DROITE = FAUX

□ Vu : 23N Q27, 19N Q7 (2×)

Définitions de taille (nodule pulmonaire) et rôle de la TDM thoracique :

- Masse = opacité > 30 mm ; nodule = 3–30 mm ; micronodule < 3 mm
- TDM : caractérisation des masses médiastinales, bilan d'extension, bilan des PID, guidage de biopsie
- Caractérise une densité graisseuse / calcique / hydrique / aérique
- Δ Micronodule = « inférieur à 3 mm » et non 3–6 mm ou 6–10 mm
- Δ La radiographie de face seule n'évalue pas l'opérabilité d'une tumeur

□ Vu : 24R Q13, 23N Q28, 21N Q11+Q13, 20R Q5, 19R Q27 (≥5×)

[RANG 2] APPROCHE DIAGNOSTIQUE D'UNE LÉSION OSSEUSE

— • ~3.14 Q/examen — 44 Q (6.3%)

Critères sémiologiques d'analyse d'une lésion osseuse (les 8 piliers) :

- L'ÂGE du patient et la LOCALISATION (sur l'os : épiphyse / métaphyse / diaphyse)
- Le NOMBRE de lésions (unique vs multiple)
- L'aspect radiologique, la VITESSE d'accroissement, les modifications structurales
- La matrice tumorale et les CALCIFICATIONS ; l'état de la corticale ; la réaction périostée

□ Vu : 24N Q33, 24R Q31, 23N Q7, 22N Q17, 21N Q20, 20N Q26... (≥8×, items répétés à chaque session)

Classification de LODWICK des ostéolyses (degré d'agressivité croissant) :

- Type IA = géographique « à l'emporte-pièce », liseré net (la moins agressive)
- Type IB = géographique à limites floues ; IC = géographique sans sclérose marginale, contours flous
- Type II = ostéolyse MITÉE ; Type III = ostéolyse PERMÉATIVE (la plus agressive)
- Évalue l'agressivité ; mitée et perméative orientent vers la malignité
- ⚠ « IA = limites floues » est faux : IA est nette à l'emporte-pièce
- ⚠ Confondre IB (limites floues) et IA (limites nettes)

□ Vu : 25J Q9, 24R Q32, 21N Q24 (3×)

Signes d'AGRESSIVITÉ / malignité d'une lésion osseuse :

- Ostéolyse mitée ou perméative à limites floues + RUPTURE de la corticale
- Réaction périostée INTERROMPUE / agressive : éperon de Codman, feu d'herbe (spiculée), bulbe d'oignon (plurilamellaire)
- L'éperon de Codman = activation des ostéoblastes sous-périostés, peut être continu ou discontinu, signe de malignité
- ⚠ L'aspect en VERRE DÉPOLI n'est PAS un critère d'agressivité retenu ici (distracteur récurrent)
- ⚠ Les niveaux liquide-liquide n'ont pas été retenus comme signe d'agressivité dans ces QE
- ⚠ Réaction périostée pleine, continue et homogène = signe de BÉNIGNITÉ, pas de malignité

□ Vu : 24R Q33, 22N Q19, 21N Q24, 19N Q18, 19R Q43-44 (≥6×)

Apport respectif de l'IRM et de la TDM dans le bilan osseux :

- IRM : extension dans les parties molles et la médullaire, régions difficiles, hypersignal T2 franc des lésions à matrice cartilagineuse/liquidienne
- TDM : analyse de la matrice, mise en évidence des calcifications, mesure de densité, guidage des biopsies
- ⚠ L'IRM n'est pas l'examen des calcifications fines (c'est la TDM)

□ Vu : 18N Q41-42, 19N Q16-17 (≥3×)

[RANG 3] TRAUMATISMES CRÂNIO-ENCÉPHALIQUES

— • ~2.93 Q/examen — 41 Q (5.9%)

CAT et examen de 1re intention devant un traumatisme crânien :

- IMMOBILISER le rachis cervical (geste prioritaire répété)
- Scanner cérébral SANS injection de produit de contraste en 1re intention + radiographie/scanner du rachis cervical
- Le scanner SPC fait le diagnostic d'hémorragie méningée au stade précoce
- ⚠ IRM cérébrale en 1re intention = FAUX (long, peu disponible en urgence)
- ⚠ Angioscanner / scanner AVEC injection en 1re intention = FAUX
- ⚠ « Radiographie / échographie / fond d'œil des pieds » = distracteurs absurdes récurrents

□ Vu : 25J Q39, 24N Q4, 24R Q3-4, 23N Q4, 22N Q5, 21N Q4-5, 18N Q22-23 (≥9×)

Hématome EXTRA-DURAL (HED) au scanner :

- Collection spontanément HYPERDENSE en LENTILLE BICONVEXE, juxta-osseuse
- LIMITÉE par les sutures crâniennes
- ⚠ « *Respecte les sutures* » associé à une forme en croissant = c'est l'HSD, pas l'HED
- ⚠ *Hypodense au scanner sans injection = FAUX (l'HED aigu est hyperdense)*

□ Vu : 24N Q5, 22N Q6, 20N Q8-9, 19N Q29 (≥5×)

Hématome SOUS-DURAL aigu (HSD) :

- Résulte de la rupture des veines cortico-durales (veines en pont)
- Forme en CROISSANT (falciforme), juxta-osseuse, hyperdense, qui FRANCHIT les sutures
- ⚠ *Siège « à la jonction substance grise / substance blanche » = c'est la contusion / lésion axonale, pas l'HSD*
- ⚠ *Forme biconvexe = HED, pas HSD*

□ Vu : 26J Q6, 20R Q35-36, 19N Q27, 19R Q17 (≥5×)

Hémorragie méningée (HSA) post-traumatique et confirmation d'anévrisme :

- Hyperdensité spontanée des espaces sous-arachnoïdiens et des citernes au scanner SPC
- Devant une HSA non traumatique : suspicion d'anévrisme → ANGIOGRAPHIE pour confirmation/datation
- ⚠ *Doppler transcrânien, doppler des vaisseaux du cou, échographie transfontanellaire ne confirment pas l'anévrisme*
- ⚠ *Hypodensité des cervelets / hypodensités linéaires des ventricules ne décrivent pas l'HSA*

□ Vu : 26J Q4-5, 22N Q3, 20N Q4, 19N Q28 (≥5×)

[RANG 4] IMAGERIE DU FOIE

— • ~2.79 Q/examen — 39 Q (5.6%)

Carcinome hépatocellulaire (CHC) — sémiologie clé :

- Tumeur hépatique maligne PRIMITIVE la plus fréquente ; forme nodulaire ou diffuse
- CHC typique = nodule hypervascularisé au temps artériel (WASH-IN) + lavage au temps portal (WASH-OUT)
- Une CAPSULE périphérique est un signe évocateur ; peut survenir sur foie sain (mais surtout cirrhose)
- ⚠ « *Survient TOUJOURS / UNIQUEMENT sur foie de cirrhose* » = FAUX (*peut survenir sur foie sain*)

□ Vu : 26J Q13, 25J Q7, 24N Q9 (3×)

Lésions hépatiques bénignes (HNF, angiome, adénome) :

- HNF : cicatrice centrale fibreuse se rehaussant au temps TARDIF ; lésion hypervasculaire
- Angiome : prise de contraste en MOTTES périphériques discontinues, remplissage centripète
- Adénome : facteur de risque = contraceptifs oraux ; risque de dégénérescence/hémorragie
- ⚠ « *HNF = lésion hypovasculaire* » = FAUX
- ⚠ « *L'adénome ne dégénère jamais* » = FAUX
- ⚠ *Contraceptifs oraux = facteur de risque de l'ADÉNOME (et non de l'angiome)*

□ Vu : 25J Q5, 24R Q9 (2×)

Cirrhose hépatique — sémiologie et étiologies :

- Foie DYSMORPHIQUE à contours IRRÉGULIERS, hétérogène/granité
- Hépatite virale C = étiologie majeure ; complication = hypertension portale
- ⚠ « *Foie homogène / contours réguliers* » = FAUX
- ⚠ « *TDM/IRM = examen de 1re intention* » = FAUX (*échographie en 1re intention*)

□ Vu : 25J Q6, 24N Q8 (2×)

Kyste hydatique du foie vs kyste biliaire simple :

- Kyste biliaire simple : anéchogène pur, paroi fine, renforcement postérieur, NE se rehausse pas
- Kyste hydatique : DD = kyste hydatique type I de Gharbi ; peut se surinfecter

- **⚠ Kyste biliaire « à paroi propre / hypersignal T1 et hyposignal T2 » = FAUX (hyposignal T1, hypersignal T2 franc)**
- **⚠ Membrane prolifère décollée / aspect multivésiculaire = kyste hydatique, pas kyste simple**

□ Vu : 24N Q7, 24R Q8, 23N Q20, 22N Q11 (≥4×)

[RANG 5] LE MÉDIASTIN NORMAL ET PATHOLOGIQUE

— • ~2.71 Q/examen — 38 Q (5.4%)

Apport du PROFIL et du signe de la silhouette dans le médiastin :

- Le profil localise le siège ANTÉRIEUR ou POSTÉRIEUR d'une opacité du cliché de face
- Signe de la silhouette = deux structures de même densité (hydrique) dont les limites s'effacent au contact
- **⚠ Le profil n'oriente PAS vers la nature maligne ni liquidienne/tissulaire d'une opacité**
- **⚠ Ne différencie pas une masse médiastinale d'une grosse artère pulmonaire (rôle de la TDM)**

□ Vu : 24R Q18, 22N Q30, 21N Q18 (3×)

Caractère MÉDIASTINAL d'une opacité (vs opacité parenchymateuse) :

- Limite externe NETTE, régulière, convexe vers le poumon
- Raccordement en PENTE DOUCE avec le médiastin ; limite interne NOYÉE dans le médiastin
- Tonalité hydrique
- **⚠ Limite externe spiculée / contours internes irréguliers = opacité parenchymateuse**
- **⚠ Bronchogramme aérien, opacité systématisée, surélévation diaphragmatique = signes alvéolaires**

□ Vu : 22N Q28, 21R Q23, 20R Q6, 19N Q8, 19R Q31 (≥5×)

Masses du médiastin POSTÉRIEUR (compartiment nerveux) :

- Tumeurs nerveuses : NEURINOMES, neurofibromes
- Méningocèles
- Causes vertébrales : spondylodiscites infectieuses, hématopoïèse extra-médullaire
- **⚠ THYMOMES = médiastin ANTÉRIEUR (piège n°1, répété 5×)**
- **⚠ Goîtres plongeants, tératomes, adénomes parathyroïdiens = médiastin antéro-supérieur**

□ Vu : 22N Q29, 20N Q22, 20R Q7, 19N Q12, 19R Q32 (≥5×)

Atélectasie du lobe supérieur droit et masses antérieures :

- Hyperdensité médiastinale supérieure droite = lésion tumorale proximale + COLLAPSUS du lobe supérieur droit
- Médiastin antéro-supérieur : goitre, lymphome, tératome, tumeur thymique
- **⚠ « Collapsus du lobe supérieur GAUCHE » dans une opacité droite = incohérence (piège)**
- **⚠ Pleurésie enkystée / épanchement péricardique = autres mécanismes**

□ Vu : 25J Q25, 22N Q31, 21N Q12, 21R Q25, 19N Q10 (≥5×)

[RANG 6] IMAGERIE PÉDIATRIQUE

— • ~2.57 Q/examen — 36 Q (5.1%)

Neuroblastome (tumeur surrénalienne maligne de l'enfant < 5 ans) :

- Tumeur qui ENGAÎNE et thrombose les vaisseaux ; souvent calcifiée
- Élévation des CATÉCHOLAMINES urinaires + scintigraphie à la MIBG = diagnostic
- BIOPSIE percutanée CONTRE-INDIQUÉE (risque de dissémination/hémorragie ; tumeur fragile)
- **⚠ « Palpation appuyée sans précaution » = FAUX (risque de rupture)**
- **⚠ Néphroblastome (Wilms) = tumeur RÉNALE, à distinguer du neuroblastome surrénalien**

□ Vu : 25J Q21, 24N Q29-30, 24R Q28 (≥4×)

Syndrome de la jonction pyélo-urétérale (SJPU) chez le nourrisson :

- Révélé par une infection urinaire ; ÉCHOGRAPHIE en 1re intention
- Dilatation pyélo-calicielle marquée avec uretère de CALIBRE NORMAL ; URO-IRM utile
- **⚠ Obstruction « urétéro-vésicale » = c'est le méga-uretère/VUP, pas le SJPU (haut)**
- **⚠ UIV demandée en 1re intention = FAUX**

□ Vu : 25J Q20, 24R Q29 (2×)

Occlusions néonatales — sémiologie de l'ASP / lavement :

- Image en DOUBLE BULLE = atrésie duodénale ; atrésie du grêle ; sténose œsophagienne ; Hirschsprung
- Lavement aux hydrosolubles = diagnostique et parfois thérapeutique
- Sténose hypertrophique du pylore : « olive pylorique » palpable, échographie de 1re intention
- **⚠ TOGD en 1re intention pour la sténose du pylore = FAUX (échographie)**
- **⚠ Pneumopéritoine / niveaux n'évoquent pas à eux seuls une étiologie précise**

□ Vu : 25J Q18, 23N Q48-50, 21N Q49, 20R Q48-50 (≥6×)

[RANG 7] MOYENS D'EXPLORATION EN NEURORADIOLOGIE

— • ~2.50 Q/examen — 35 Q (5.0%)

Scanner cérébral SANS injection — caractéristiques et indications :

- Utilise les RAYONS X ; rapide (≈ qq minutes) ; 1re intention en traumatisme crânien
- Diagnostic d'hémorragie méningée au stade précoce ; hyperdensité spontanée des espaces sous-arachnoïdiens
- **⚠ « Non invasif sans contre-indication, utilise des ultrasons, dure 25 min » = FAUX**
- **⚠ Contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale = FAUX (c'est l'injection iodée qui pose problème)**

□ Vu : 26J Q1-2, 22N Q3, 20N Q2 (≥4×)

Contre-indications de l'IRM cérébrale :

- Pacemaker / défibrillateur implantable
- Corps étranger métallique INTRA-OCULAIRE
- Clips vasculaires ferromagnétiques ; matériel d'ostéosynthèse ferromagnétique
- **⚠ Dispositif intra-utérin (stérilet), appareil/implant dentaire, grossesse = NON contre-indiqués (pièges très répétés)**
- **⚠ Allergie aux œufs, claustrophobie isolée = ne sont pas des CI absolues**

□ Vu : 25J Q35, 24N Q2, 22N Q1-2, 21N Q2, 21R Q3, 19N Q25, 19R Q15 (≥8×)

Angiographie cérébrale et angioscanner :

- Angiographie : technique INVASIVE, utilise les rayons X, opacifie les vaisseaux ; cartographie vasculaire des tumeurs hypervascularisées
- Angioscanner : explore le tronc basilaire, la carotide intracrânienne et ses branches ; recherche d'anévrisme
- **⚠ Angioscanner explore « les faisceaux de substance blanche / le flux du LCR » = FAUX**
- **⚠ L'angiographie n'est pas non invasive**

□ Vu : 26J Q1, 24N Q1, 23N Q2-3 (≥4×)

[RANG 8] EXPLORATION RADIOLOGIQUE DU PELVIS FÉMININ

— • ~2.43 Q/examen — 34 Q (4.9%)

Hystérosalpingographie (HSG) — indications et contre-indications :

- INDICATIONS : bilan d'infertilité (perméabilité tubaire), recherche de malformation utérine, synéchie, cathétérisme de reperméabilisation tubaire

- CONTRE-INDICATIONS : GROSSESSE, infection génitale en cours, hémorragie génitale abondante, allergie à l'iode
- ⚠ L'HSG n'explore pas un fibrome / une tumeur ovarienne (c'est l'échographie/IRM)
- ⚠ « Avortements à répétition / endométriose » ne sont pas l'indication princeps de l'HSG

□ Vu : 24R Q46, 24N Q48, 22N Q42, 20N Q45, 19R Q6-7, 18N Q33 (≥6×)

IRM pelvienne — place dans la pathologie gynécologique :

- Bilan d'extension du cancer du COL et de l'ENDOMÈTRE
- Diagnostic d'endométriose, malformations utérines, troubles de la statique pelvienne
- Meilleure caractérisation tissulaire (kystique/solide/gras/calcique d'une masse)
- ⚠ TDM pelvienne / AUSP / cystographie comme examen princeps de la pathologie utéro-ovarienne = FAUX (distracteurs très répétés)
- ⚠ Artériographie utérine = thérapeutique (embolisation), pas diagnostique de 1re ligne

□ Vu : 25J Q49-50, 24R Q50, 23N Q44-46, 22N Q41-43 (≥8×)

[RANG 9] IMAGERIE DES CANCERS BRONCHO-PULMONAIRES

— • ~2.21 Q/examen — 31 Q (4.4%)

Bilan d'extension et classification TNM du CBP :

- TDM thoraco-abdominale : staging TNM, opérabilité, RCP
- Diagnostic de présomption à l'imagerie ; confirmation HISTOLOGIQUE indispensable (biopsie)
- RECIST = évaluation de la réponse thérapeutique
- ⚠ « Le stade T reflète l'extension ganglionnaire » = FAUX (T = tumeur ; N = ganglions)
- ⚠ Scintigraphie de ventilation/perfusion systématique = FAUX

□ Vu : 26J Q37, 25J Q34 (≥3×)

Signe de Golden (« S » inversé) et tumeur de l'apex :

- Signe « S » de Golden = bombement paradoxal de la scissure devant une tumeur proximale obstructive
- Tumeur à contours irréguliers spiculés, pouvant s'excaver et envahir la paroi
- ⚠ « Double contour de l'arc inférieur droit / signe du rétrécissement mitral » = autre contexte (piège)
- ⚠ « Pathognomonique du rétrécissement mitral » = FAUX

□ Vu : 26J Q33, 24N Q18, 24R Q25 (≥3×)

Contre-indications de la ponction-biopsie trans-thoracique scanno-guidée :

- Troubles de l'hémostase ; HTAP sévère ; insuffisance respiratoire sévère ; patient non coopérant ; suspicion de kyste hydatique
- ⚠ Complications de la biopsie : PNEUMOTHORAX, hémorragie alvéolaire, hémothorax, embolie gazeuse (et non « collapsus » ou « atélectasie »)

□ Vu : 22N Q33, 21N Q14, 20R Q14, 19N Q13-14, 18N Q13-14 (≥6×)

[RANG 10] LES TUMEURS OSSEUSES MALIGNES

— • ~2.07 Q/examen — 29 Q (4.1%)

Ostéosarcome — terrain et séméiologie radiologique :

- Tumeur maligne ostéoformatrice ; sujet jeune ; siège MÉTAPHYSAIRE des os longs (près du genou, loin du coude)
- Lésion MIXTE (ostéolyse + ostéocondensation), ostéolyse perméative/mitée (type III/IC de Lodwick)
- Réaction périostée agressive : éperon de Codman, feu d'herbe, bulbe d'oignon ; envahit les parties molles
- ⚠ « Réaction périostée pleine, continue et homogène » = signe de bénignité, PAS ostéosarcome
- ⚠ « Ostéolyse de type IA » = lésion bénigne, pas un ostéosarcome

- **⚠ Siège épiphysaire = oriente vers chondroblastome / TCG, pas ostéosarcome**

□ Vu : 26J Q17, 25J Q10, 24N Q38, 24R Q36, 22N Q22, 21N Q26-28, 20N Q28-29 (≥9×)

Bilan d'extension d'une tumeur osseuse maligne :

- IRM de l'os concerné AVANT la biopsie (extension médullaire et parties molles)
- TDM thoracique (métastases pulmonaires) + scintigraphie osseuse (lésions à distance)
- **⚠ IRM/TDM CÉRÉBRALE dans le bilan d'extension osseux courant = FAUX (distracteur)**
- **⚠ Demander la biopsie AVANT l'IRM = FAUX (l'IRM précède la biopsie)**

□ Vu : 26J Q18, 19N Q21, 19R Q45, 18N Q47 (≥4×)

[RANG 11] SYNDROME ALVÉOLAIRE ET INTERSTITIEL

— • ~2.00 Q/examen — 28 Q (4.0%)

Syndrome ALVÉOLAIRE — sémiologie radiologique :

- Opacité CONFLUENTE, SYSTÉMATISÉE, à LIMITES FLOUES, à BRONCHOGRAMME AÉRIEN
- Évolution RAPIDE ; aspect en « ailes de papillon » dans l'OAP
- Étiologies : pneumopathies infectieuses/virales, OAP, hémorragie, carcinome bronchiolo-alvéolaire
- **⚠ « Opacité à limites nettes, non systématisée, d'évolution lente » = syndrome interstitiel, pas alvéolaire**
- **⚠ La présence d'un bronchogramme aérien n'exclut PAS une pneumopathie bactérienne ni un cancer**

□ Vu : 25J Q23, 24N Q23, 24R Q19, 23N Q32, 22N Q27, 21N Q10, 20N Q17, 20R Q3 (≥8×)

Syndrome INTERSTITIEL — sémiologie radiologique :

- Micronodules à LIMITES NETTES, images en VERRE DÉPOLI
- Épaississement péri-broncho-vasculaire et des septa ; images kystiques / rayon de miel (fibrose)
- Évolution plutôt LENTE ; lésions non systématisées
- **⚠ « Micronodules à limites floues / opacités confluentes systématisées » = syndrome alvéolaire**
- **⚠ Rayon de miel = fibrose interstitielle, pas un syndrome alvéolaire**

□ Vu : 26J Q30, 25J Q22, 20N Q18, 20R Q4, 19N Q4, 18N Q11 (≥6×)

[RANG 12] EXPLORATION RADIOLOGIQUE DE L'APPAREIL URINAIRE

— • ~1.79 Q/examen — 25 Q (3.6%)

AUSP (arbre urinaire sans préparation) et URO-SCANNER :

- AUSP : doit couvrir TOUT l'appareil urinaire ; analyse squelette, bords des psoas, ombres rénales, trajet urétéral
- Uro-scanner SANS contraste = 1re intention devant une colique néphrétique (recherche de calcul)
- URO-IRM sans gadolinium (femme enceinte, dilatation)
- **⚠ L'UIV n'est plus l'examen de 1re intention (largement remplacée par l'uro-scanner)**
- **⚠ L'AUSP ne fait pas le diagnostic de cancer de prostate**

□ Vu : 26J Q40+Q42, 24N Q42-43, 24R Q38-39, 21R Q34 (≥6×)

Urétéro-cystographie rétrograde (UCR) — indications :

- Recherche de STÉNOSE URÉTRALE ; valve de l'urètre postérieur (VUP) chez le garçon
- Recherche de reflux vésico-urétéral (par cystographie mictionnelle)
- **⚠ UIV pour explorer une sténose urétrale = FAUX (c'est l'UCR)**

□ Vu : 24R Q41, 23N Q40-41, 22N Q39, 20N Q43, 19N Q43, 19R Q10 (≥6×)

[RANG 13] LES TUMEURS OSSEUSES BÉNIGNES

— • ~1.71 Q/examen — 24 Q (3.4%)

Caractères radiologiques communs de BÉNIGNITÉ :

- Ostéolyse géographique TYPE IA de Lodwick (à l'emporte-pièce) avec liseré de condensation marginale
- RESPECT de la corticale ; réaction périostée (si présente) continue, pleine et homogène ; évolution lente
- ⚠ Ostéolyse mitée/perméative, réaction plurilamellaire, éperon de Codman, infiltration des parties molles, réaction spiculée = signes de MALIGNITÉ (jamais bénin)

□ Vu : 26J Q19-20, 25J Q11-12, 24N Q36-37, 24R Q34-35, 23N Q11-12 (≥10×)

Chondrome / enchondrome et autres bénignes typiques :

- Chondrome : tumeur CARTILAGINEUSE, la plus fréquente des os de la MAIN, lacune à calcifications ; peut dégénérer (chondrosarcome)
- Ostéome ostéoïde : douleur NOCTURNE calmée par l'ASPIRINE, nidus avec ostéocondensation périphérique
- Ostéochondrome (exostose) : métaphysaire, sessile ou pédiculé, peut dégénérer
- ⚠ Ostéome ostéoïde « jamais douloureux » = FAUX (douleur nocturne typique)
- ⚠ Chondrome présenté comme « tumeur ostéoblastique / kystique » = FAUX (cartilagineuse)

□ Vu : 26J Q20-21, 25J Q12, 23N Q12, 21N Q25, 21R Q13, 19N Q20, 18N Q43-44 (≥8×)

[RANG 14] EXPLORATION RADIOLOGIQUE DU SEIN

— • ~1.57 Q/examen — 22 Q (3.1%)

Indications préférentielles de l'ÉCHOGRAPHIE mammaire (vs mammographie) :

- 1re intention chez la FEMME JEUNE (< 30 ans), ENCEINTE ou ALLAITANTE, et sur SEINS DENSES
- Contexte de mastite / abcès / inflammation mammaire ; traumatisme
- Complément de la mammographie pour caractériser une lésion (kystique vs solide)
- ⚠ L'échographie n'est PAS l'examen des microcalcifications (c'est la mammographie)
- ⚠ Mammographie en 1re intention chez la femme allaitante / sein inflammatoire = FAUX

□ Vu : 26J Q47, 25J Q46, 24R Q44-45+Q49, 22N Q47-48, 21N Q41-43, 21R Q36, 19R Q1-2 (≥9×)

Diagnostics différentiels d'une collection / masse du sein en échographie :

- Mastite compliquée ou non d'ABCÈS mammaire ; dystrophie kystique ; hématome ; tumeur bénigne vs cancer
- ⚠ TDM mammaire / galactographie comme examens de débrouillage = FAUX (la galactographie explore un écoulement)

□ Vu : 24R Q43, 22N Q47, 21N Q41, 20R Q41 (≥4×)

[RANG 15] ABDOMEN AIGU

— • ~1.57 Q/examen — 22 Q (3.1%)

Volvulus du côlon sigmoïde — signes radiologiques :

- Image en « ARCEAU » / « grain de café » du sigmoïde, ampoule rectale VIDE
- Signe du TOURBILLON au scanner ; arrêt en « bec d'oiseau » au lavement
- ⚠ Image en « trognon de pomme » = sténose tumorale colique, pas un volvulus
- ⚠ Image en cocarde / cible = invagination intestinale

□ Vu : 25J Q2, 24N Q10 (≥2×)

Pneumopéritoine et causes d'« abdomen aigu non chirurgical » trompeuses :

- Pneumopéritoine = croissant gazeux clair sous-diaphragmatique sur ASP/radio centrée sur les coupes DEBOUT

- Causes médicales simulant un abdomen aigu : IDM, pancréatite aiguë, perforation d'ulcère, infarctus mésentérique
- *⚠ Lithiase vésiculaire SIMPLE / appendicite ne donnent pas de pneumopéritoine*
- *⚠ Aérobie et calcifications sous-hépatiques ≠ pneumopéritoine*

□ Vu : 24N Q11-12, 22N Q13+Q16, 21R Q48-50, 20N Q37-38, 20R Q16-17 (≥8×)

Examen de 1re intention devant une occlusion / urgence abdominale :

- ASP DEBOUT (niveaux hydro-aériques : grêle = centraux, plus larges que hauts ; côlon = périphériques, plus hauts que larges)
- Angioscanner abdomino-pelvien si suspicion vasculaire (anévrisme rompu, dissection, infarctus mésentérique)
- *⚠ IRM abdominale en 1re intention en urgence = FAUX*
- *⚠ Endoscopie / fibroscopie comme examen radiologique d'urgence d'occlusion = FAUX*

□ Vu : 24R Q12, 22N Q14, 21R Q47, 20N Q36, 18N Q20 (≥5×)

[RANG 16] IMAGERIE DES VOIES BILIAIRES

— • ~1.50 Q/examen — 21 Q (3.0%)

Lithiase biliaire — signe échographique cardinal :

- Image HYPERÉCHOGÈNE avec CÔNE D'OMBRE postérieur, mobile et déclive
- Hyposignal T2 en bili-IRM ; non hypervascularisée au Doppler
- *⚠ « Renforcement postérieur des échos » = c'est un kyste, pas une lithiase (qui donne un cône d'ombre)*
- *⚠ « Toujours radio-opaque à l'ASP / toujours visible au scanner » = FAUX (la plupart sont radio-transparents)*
- *⚠ Mobilité = signe de bénignité, pas de malignité*

□ Vu : 26J Q11, 25J Q3, 24R Q10, 22N Q8, 21R Q45, 20N Q33, 18N Q17 (≥7×)

Cholécystite aiguë lithiasique — critères échographiques :

- Paroi vésiculaire ÉPAISSIE > 4 mm + lithiase ; épanchement et infiltration de la graisse péri-vésiculaire ; Murphy échographique
- *⚠ « Paroi fine < 4 mm, bile fluide » = vésicule normale, pas une cholécystite*
- *⚠ Complications de la lithiase = cholécystite, angiocholite, pancréatite (et non « cancer/polype » d'emblée)*

□ Vu : 26J Q12, 25J Q3, 24R Q10, 23N Q19, 21N Q31, 19N Q32 (≥6×)

Stratégie d'exploration de la voie biliaire principale :

- Échographie hépatobiliaire en 1re intention ; BILI-IRM (cholangio-IRM) = référence non invasive ; écho-endoscopie pour les petits calculs cholédociens
- *⚠ ASP / angioscanner / artériographie pour explorer les voies biliaires = FAUX*

□ Vu : 26J Q10, 23N Q16-17, 21N Q30, 19N Q31, 19R Q37 (≥5×)

[RANG 17] SYNDROME OBSTRUCTIF DES VOIES URINAIRES

— • ~1.36 Q/examen — 19 Q (2.7%)

Bilan d'un syndrome obstructif urinaire bas / prostatique :

- IRM PROSTATIQUE pour le bilan local (signe le plus répété de cette leçon)
- Échographie en 1re intention (normale au stade de début) ; sténose urétrale comme cause obstructive
- Uro-scanner sans contraste pour le retentissement et la cause
- *⚠ L'échographie peut être normale au tout début → ne pas l'utiliser seule pour éliminer l'obstruction*
- *⚠ AUSP / UIV comme examen princeps de l'obstruction prostatique = FAUX*

□ Vu : 26J Q43-44, 25J Q41+Q43, 23N Q43, 22N Q44, 21N Q48, 21R Q35 (≥7×)

[RANG 18] IMAGERIE DES AVC

— • ~1.29 Q/examen — 18 Q (2.6%)

Signes PRÉCOCES (< 6 h) de l'AVC ischémique au scanner SPC :

- HYPERDENSITÉ spontanée de l'artère cérébrale moyenne (sylvienne) = thrombus
- Effacement du RUBAN CORTICAL / insulaire avec dédifférenciation substance grise–blanche
- Effacement du noyau LENTICULAIRE ; effacement des sillons corticaux
- ⚠ « Hyperdensité spontanée des méninges » = HSA, pas un AVC ischémique
- ⚠ Prise de contraste intense et diffuse / gyriforme = stade tardif (subaigu), pas précoce

□ Vu : 26J Q3, 25J Q38, 20N Q5, 19N Q26 (≥4×)

Chronologie densitométrique de l'infarctus constitué :

- < 24 h : signes précoces subtils ; 24 h–1 mois : HYPODENSITÉ SYSTÉMATISÉE à un territoire vasculaire
- Au-delà : cavité porencéphalique séquellaire (hypodensité hydrique rétractile)
- ⚠ « Hyperdensité spontanée systématisée » d'un infarctus = FAUX (l'infarctus est HYPODENSE)
- ⚠ « Hypodensité mal systématisée / en lentille biconvexe » = autre diagnostic

□ Vu : 24N Q6, 24R Q6, 22N Q7, 21N Q7, 21R Q7, 18N Q28 (≥6×)

Hématome intra-cérébral (AVC hémorragique) :

- Diagnostiqué dès les premières minutes sur le scanner SPC (hyperdensité spontanée intra-parenchymateuse)
- Étiologie n°1 = HTA ; autres : rupture d'anévrisme/MAV, troubles de la coagulation
- ⚠ « Invisible avant 24 h, mieux vu sur IRM, diagnostic clinique » = FAUX (visible d'emblée au scanner)
- ⚠ Un traumatisme minime n'est pas une cause d'hématome intracérébral non traumatique

□ Vu : 25J Q37, 20N Q6, 18N Q26-27 (≥4×)

[RANG 19] IMAGERIE DES INFECTIONS PULMONAIRES

— • ~1.29 Q/examen — 18 Q (2.6%)

Primo-infection tuberculeuse — sémiologie :

- Suit le 1er contact avec le BK ; souvent SANS traduction radiologique
- Forme typique = COMPLEXE PRIMAIRE (chancr d'inoculation + adénopathie satellite)
- Peut donner un nodule de faible tonalité à la base droite ; nodule calcifié séquellaire
- ⚠ « Présente TOUJOURS une traduction radiologique » = FAUX
- ⚠ Germe ANAÉROBIE = FAUX (le BK est aérobic strict)

□ Vu : 22N Q36, 21N Q16, 21R Q31, 20N Q23 (≥4×)

Tuberculose pulmonaire commune et COVID-19 :

- TB commune : excavations APICALES, micronodules « arbre en bourgeon », opacités nodulaires/alvéolaires, ADP médiastinale
- COVID-19 : verre dépoli bilatéral périphérique des bases, classification CO-RADS, risque d'embolie pulmonaire, surinfection bactérienne possible
- ⚠ « COVID = origine virale rare, nettoyage radiologique précoce » = FAUX (dissociation radio-clinique : retard radiologique)
- ⚠ Angioscanner systématique au COVID = FAUX (si suspicion d'EP seulement)

□ Vu : 25J Q30-31, 24N Q16, 24R Q22+Q24 (≥5×)

[RANG 20] IMAGERIE DU TUBE DIGESTIF

— • ~1.29 Q/examen — 18 Q (2.6%)

Examen de référence du rectum et des MICI :

- IRM PELVIENNE pour le rectum (cancer, fistules périnéales) et le bilan d'extension
- Entéro-scanner/IRM dans les MICI : épaississement digestif, sclérolipomatose, adénopathies mésentériques, fistules
- *⚠ Coloscopie / lavement baryté présentés comme examen radiologique d'extension = FAUX (la coloscopie n'est pas de l'imagerie en coupe)*
- *⚠ Échographie/scanner pelvien comme référence du bas rectum = FAUX*

□ Vu : 25J Q1, 24N Q14, 21N Q35, 21R Q44, 20N Q32, 20R Q21, 19N Q36, 18N Q19 (≥8×)

Sténose tumorale et atrésie de l'œsophage :

- Cancer colique : image en « TROGNON DE POMME » (sténose courte, irrégulière, asymétrique, angles aigus)
- Atrésie de l'œsophage : anomalie congénitale la plus fréquente ; type III de Ladd le plus fréquent ; sonde enroulée dans le cul-de-sac supérieur
- *⚠ Image en cocarde/cible/grain de café ≠ sténose tumorale œsophagienne*
- *⚠ Sténose bénigne = courte, régulière, raccordement en pente douce (à l'opposé du trognon de pomme)*

□ Vu : 26J Q38-39, 24N Q10, 20N Q35, 19N Q38, 19R Q36 (≥5×)

[RANG 21] EXPLORATION RADIOLOGIQUE DU RACHIS

— • ~1.21 Q/examen — 17 Q (2.4%)

Incidences radiographiques du rachis et éléments analysés :

- Incidences de FACE, de PROFIL, OBLIQUES (3/4, étude des isthmes et foramens), face haute bouche ouverte (C1-C2), clichés DYNAMIQUES flexion/extension
- Analyse : statique rachidienne, hauteur des corps vertébraux, espaces intervertébraux, foramens, isthmes, pédicules, massifs articulaires postérieurs
- *⚠ Les incidences obliques explorent surtout les ISTHMES et FORAMENS (pièges fréquents avec le corps vertébral)*
- *⚠ Confondre l'étude de la statique (clichés debout) avec un cliché de profil couché*

□ Vu : 25J Q17, 24N Q40-41, 23N Q14-15, 22N Q24-25, 20R Q30, 18N Q49 (≥9×)

Signes radiologiques de l'arthrose rachidienne :

- PINCEMENT de l'interligne articulaire
- OSTÉOCONDENSATION sous-chondrale
- OSTÉOPHYTOSE marginale
- GÉODES sous-chondrales
- *⚠ SYNDESMOPHYTES = spondylarthrite ankylosante, PAS arthrose (à ne pas confondre avec l'ostéophyte)*

□ Vu : 18N Q50 (signes classiques de l'arthrose)

[RANG 22] EXPLORATION RADIOLOGIQUE D'UNE MASSE PELVIENNE

— • ~1.14 Q/examen — 16 Q (2.3%)

Examen de 1re intention devant une masse pelvienne :

- ÉCHOGRAPHIE (sus-pubienne + endovaginale) en 1re intention ; IRM en 2e intention pour caractériser/étendre
- Kyste fonctionnel : masse à contrôler en échographie au cycle suivant

- **⚠ TDM pelvienne / cystographie / UIV / ASP / artériographie en 1re intention = FAUX (distracteurs très répétés)**
- **⚠ PET-scanner comme examen de débrouillage = FAUX**

□ Vu : 26J Q48+Q50, 24N Q47+Q50, 24R Q48, 21R Q37+Q40, 19R Q3+Q9 (≥8×)

Diagnosics d'une masse pelvienne DOULOUREUSE aiguë :

- Grossesse extra-utérine (GEU)
- Torsion de kyste ovarien
- Fibrome utérin en nécrobiose aseptique
- **⚠ Grossesse intra-utérine simple / appendicite / endométrite ne sont pas la réponse attendue à « masse pelvienne aiguë »**

□ Vu : 26J Q49, 24R Q47, 21R Q39, 19R Q8 (≥4×)

[RANG 23] LES OSTÉO-ARTHRITES — OSTÉOMYÉLITE

— • ~1.00 Q/examen — 14 Q (2.0%)

Ostéomyélite aiguë vs chronique — sémilogie :

- Aiguë : ostéolyse mitée métaphysaire, réaction périostée, gonflement des parties molles ; SÉQUESTRE osseux
- Chronique : remodelage et ÉPAISSISSEMENT de la corticale, séquestre, fistules, géodes en miroir
- **⚠ « Réaction périostée en feu d'herbe / éperon de Codman » = malignité (ostéosarcome), pas ostéomyélite**
- **⚠ Localisation épiphysaire d'emblée = atypique pour l'ostéomyélite hématogène (métaphysaire)**

□ Vu : 26J Q23-24, 25J Q14-15, 24R Q37, 22N Q23, 20R Q29, 19N Q23, 19R Q48, 18N Q48 (≥9×)

Abcès de Brodie (ostéomyélite chronique localisée) :

- Lacune de type IA de Lodwick avec OSTÉOSCLÉROSE marginale, métaphysaire, peut contenir un séquestre
- Diagnostic différentiel principal = OSTÉOME OSTÉOÏDE
- **⚠ Présenté comme « tumeur cartilagineuse » = FAUX (origine infectieuse)**

□ Vu : 21N Q29, 21R Q17, 23N Q13, 20R Q28, 18N Q48 (≥5×)

[RANG 24] SYNDROME BRONCHIQUE ET TROUBLES DE LA VENTILATION

— • ~1.00 Q/examen — 14 Q (2.0%)

Signes DIRECTS et INDIRECTS de l'atélectasie (collapsus) :

- Direct : opacité rétractile + DÉPLACEMENT et DÉFORMATION du hile attiré vers le lobe collabé ; déplacement scissural vers le côté collabé
- Indirects (de RÉTRACTION) : attraction du médiastin vers le côté pathologique, surélévation de la coupole homolatérale, PINCEMENT des espaces intercostaux, hyperaération compensatrice controlatérale
- **⚠ ABAISSEMENT de la coupole / ÉLARGISSEMENT des espaces intercostaux = signes d'hyperinflation, à l'OPPOSÉ de l'atélectasie (pièges répétés)**
- **⚠ Refoulement du médiastin vers le côté controlatéral = effet de masse, pas une atélectasie pure**

□ Vu : 25J Q26, 24N Q28, 24R Q16, 23N Q38, 22N Q34, 21N Q19, 20N Q21, 19N Q6, 19R Q30, 18N Q7 (≥10×)

Corps étranger inhalé et trouble de ventilation localisé :

- PIÉGEAGE d'air sur les clichés inspiration/expiration (emphysème obstructif localisé)
- Rechercher un syndrome de pénétration ; bronchoscopie en urgence pour extraction ; risque vital si migration trachéale

- **⚠ « Une simple surveillance suffit » devant un corps étranger inhalé = FAUX**

□ Vu : 18N Q40 (corps étranger / piégeage)

[RANG 25] SYNDROME DE MASSE RÉNALE

— • ~0.86 Q/examen — 12 Q (1.7%)

Kyste rénal SIMPLE (Bosniak I) — critères :

- Contenu LIQUIDIEN PUR, paroi FINE, contours réguliers, NON vascularisé au Doppler/après injection
- Échographie en 1re intention ; pas besoin de confirmation histologique
- **⚠ « Paroi épaissie, contours irréguliers, vascularisé » = kyste atypique/malin, PAS un kyste simple**
- **⚠ L'AUSP/UIV comme examen de choix d'une masse rénale = FAUX (échographie puis uro-TDM)**

□ Vu : 25J Q42, 24N Q44, 20N Q41, 19N Q44, 18N Q35 (≥5×)

Classification de BOSNIAK et caractérisation d'un kyste atypique :

- Bosniak I = kyste simple bénin ; type IV = suspect de malignité (paroi/cloisons épaisses rehaussées, végétations)
- Kyste atypique : exploration par TDM/IRM avec et sans injection ; surveillance ou geste selon le type
- **⚠ Classer un kyste simple en « type IV » = FAUX**
- **⚠ « L'échographie suffit pour un kyste atypique » = FAUX (TDM/IRM nécessaires)**

□ Vu : 24N Q44, 24R Q40, 22N Q40 (≥3×)

[RANG 26] IMAGERIE DU PANCRÉAS

— • ~0.79 Q/examen — 11 Q (1.6%)

Pancréatite aiguë — diagnostic et score de Balthazar :

- Diagnostic = douleur abdominale aiguë + lipasémie > 3 N ; TDM injectée à 48–72 h pour la GRAVITÉ
- Densification de la graisse péri-pancréatique = stade C de Balthazar ; nécrose = zone non rehaussée
- Un scanner NORMAL n'élimine PAS une pancréatite ; faux kyste = complication tardive
- **⚠ « Échographie = examen de référence en urgence » = FAUX (TDM ; l'écho cherche la lithiase)**
- **⚠ « Scanner dès la 1re heure pour un diagnostic fiable » = FAUX (réalisé à 48–72 h pour le pronostic)**
- **⚠ « Balthazar repose sur la lipasémie » = FAUX (score morphologique TDM)**

□ Vu : 26J Q8, 24N Q13, 24R Q11 (≥3×)

Adénocarcinome et pancréatite chronique :

- ADK = type histologique le plus fréquent ; signes indirects = dilatation des voies biliaires et du Wirsung ; IRM > TDM/écho pour la détection ; queue = limite de l'échographie
- Pancréatite chronique : CALCIFICATIONS parenchymateuses, dilatation du Wirsung, ATROPHIE glandulaire
- **⚠ « Échographie = examen le plus performant pour les pseudo-anévrysmes » = FAUX (TDM/angio)**
- **⚠ « Hypervascularisation intense au temps artériel » de l'ADK = FAUX (tumeur HYPO-vascularisée)**

□ Vu : 26J Q7+Q9, 23N Q22, 21N Q32, 19N Q33 (≥5×)

[RANG 27] RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

— • ~0.64 Q/examen — 9 Q (1.3%)

Technique de Seldinger et radiologie vasculaire :

- Seldinger = étape initiale d'abord vasculaire (ponction → guide → cathéter de calibre variable)
- Permet des gestes THÉRAPEUTIQUES (pas seulement diagnostiques) : embolisation des hémoptysies, traitement de certaines tumeurs

- **⚠ « Chirurgie à cœur ouvert / seulement diagnostique / sans risque » = FAUX**
- **⚠ Guidage par scanner « tout au long » d'un geste vasculaire = FAUX (scopie pour l'endovasculaire)**

□ Vu : 25J Q32, 24N Q17 (≥2×)

Microbiopsie percutanée guidée — contre-indications et complications :

- Microbiopsie sous guidage échographique ou scanner ; CI : troubles de l'hémostase, HTAP, insuffisance respiratoire sévère, suspicion de kyste hydatique
- **⚠ Complications : pneumothorax, hémorragie intra-alvéolaire, hémomédiastin (et non « collapsus »)**
- **⚠ Biopsie chirurgicale / bronchoscopie / cytoponction ≠ microbiopsie percutanée**

□ Vu : 25J Q33, 24N Q19, 21R Q28, 20N Q13-14 (≥4×)

[RANG 28] EXPLORATION RADIOLOGIQUE DU NODULE DU SEIN

— • ~0.64 Q/examen — 9 Q (1.3%)

Caractérisation d'un nodule en échographie/mammographie :

- Nodule BÉNIN (type fibroadénome) : ovale, grand axe PARALLÈLE à la peau, contours réguliers, macrocalcifications en « pop-corn », fréquent < 30 ans
- Kyste compliqué : cloisons épaisses, végétations endokystiques → vérification cytologique
- **⚠ « Contours mal limités / non parallèle à la peau » = critères de MALIGNITÉ**
- **⚠ Microcalcifications « rondes et régulières / poussiéreuses » à tort présentées comme suspectes : ce sont les microcalcifications VERMICULAIRES, branchées, < 0,5 mm qui inquiètent**

□ Vu : 25J Q45+Q47-48 (≥3×)

Examen adapté à l'exploration d'un nodule du sein :

- ÉCHOGRAPHIE (femme jeune) + MAMMOGRAPHIE (microcalcifications) ; biopsie sous guidage échographique pour la preuve
- **⚠ IRM mammaire / galactographie / TDM en 1re ligne pour un nodule = FAUX (galactographie = écoulement mamelonnaire)**

□ Vu : 24N Q49, 23N Q47, 20N Q46, 20R Q40 (≥4×)

[RANG 29] SYNDROME PLEURAL

— • ~0.57 Q/examen — 8 Q (1.1%)

PNEUMOTHORAX — séméiologie radiologique :

- HYPERCLARTÉ avasculaire périphérique avec MOIGNON pulmonaire rétracté contre le médiastin
- Si compressif : élargissement des espaces intercostaux, abaissement de la coupole, refoulement du médiastin vers le côté CONTROLATÉRAL
- **⚠ « ATTRACTION du hile vers le pneumothorax » = FAUX (c'est un refoulement/rétraction inverse) — piège répété 4×**
- **⚠ Surélévation de la coupole homolatérale / attraction du médiastin homolatéral = atelectasie, pas pneumothorax**

□ Vu : 26J Q31, 24R Q17, 22N Q35, 21R Q29, 20N Q20 (≥5×)

Épanchement pleural liquidien de FAIBLE abondance — détection :

- Cliché en DÉCUBITUS LATÉRAL à rayon horizontal ; ÉCHOGRAPHIE de la base thoracique
- Opacité déclive effaçant la coupole / le bord du cœur (signe de la silhouette)
- **⚠ Cliché en expiration forcée / position assise inspiration profonde / décubitus dorsal rayon vertical = non adaptés pour un épanchement minime**

□ Vu : 23N Q37+Q39, 18N Q6 (≥2×)

[RANG 30] LES SPONDYLODISCITES

— • ~0.14 Q/examen — 2 Q (0.3%)

Spondylodiscite infectieuse — sémiologie radiologique :

- PINCEMENT discal précoce, érosion des plateaux vertébraux, GÉODES EN MIROIR de part et d'autre du disque
- Tassement cunéiforme, séquestres osseux ; IRM = examen le plus sensible et précoce
- ⚠ « Vertèbre ivoire » = métastase ostéocondensante / Hodgkin, PAS une spondylodiscite
- ⚠ L'analyse porte sur les corps vertébraux et le disque (pas sur les lames/apophyses transverses)

□ Vu : 25J Q16, 24N Q39 (≥2×)

PARTIE 4 — TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER — À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé — NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK — BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~0% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

(Aucun topic hors programme — tous les topics correspondent aux leçons officielles cette année.)

AIDE-MÉMOIRE FINAL — HIGH-YIELD CONCOURS RADIOLOGIE

** CLASSIFICATIONS & SCORES À RETENIR **

Lésion osseuse (ostéolyse)	LODWICK : IA emporte-pièce · IB/IC flou · II mitée · III perméative
Kyste rénal	BOSNIAK I (simple bénin) → IV (suspect malin)
Kyste hydatique du foie	GHARBI type I → V (calcifié)
Pancréatite aiguë (TDM)	BALTHAZAR A→E (+ score de nécrose = CTSI)
Cancer broncho-pulmonaire	TNM (T tumeur · N ganglions · M métastases) · réponse = RECIST
COVID-19 / pneumopathie virale	CO-RADS (scanner thoracique)

** EXAMEN DE 1re INTENTION — LE RÉFLEXE QUI RAPPORTE **

Marqueur / Critère	Indication
Traumatisme crânien	Scanner cérébral SANS injection + rachis cervical
Colique néphrétique	Uro-scanner SANS contraste (AUSP couvrant tout l'appareil)
Masse pelvienne / pathologie gynéco	Échographie (sus-pubienne + endovaginale), IRM en 2e
Sein : jeune / enceinte / allaitante / dense / inflammatoire	Échographie mammaire
Sein : microcalcifications	Mammographie
Voie biliaire principale	Échographie → bili-IRM (référence non invasive)
Pancréatite aiguë (gravité)	TDM injectée à 48–72 h
Masse rénale / kyste	Échographie → uro-TDM avec et sans injection
AVC (1re intention)	Scanner cérébral SANS injection
Rectum / MICI / cancer du col-endomètre	IRM pelvienne

** PIÈGES CLASSIQUES DU CONCOURS (FAUX récurrents) **

- **△ HED** = lentille biconvexe, LIMITÉE par les sutures ; **HSD** = croissant, FRANCHIT les sutures (ne pas inverser).
- **△ Infarctus constitué** = HYPODENSITÉ systématisée ; l'« hyperdensité systématisée » est un piège — seul le thrombus (artère sylvienne) est hyperdense.
- **△ THYMOME** = médiastin ANTÉRIEUR (jamais postérieur) ; le médiastin postérieur = tumeurs nerveuses, méningocèles.
- **△ Pneumothorax** : moignon RÉTRACTÉ contre le médiastin — « attraction du hile vers le pneumothorax » est FAUX.
- **△ Atélectasie** = signes de RÉTRACTION (pincement intercostal, surélévation coupole) ; abaissement coupole + élargissement intercostal = piège inverse.
- **△ Lithiase biliaire** = cône d'ombre postérieur ; un kyste donne un RENFORCEMENT postérieur (ne pas confondre).
- **△ Stérilet**, appareil dentaire et grossesse ne sont PAS des contre-indications de l'IRM.
- **△ Un scanner abdominal NORMAL** n'élimine pas une pancréatite aiguë ; l'ADK pancréatique est HYPO-vascularisé.

- **⚠** Lodwick IA = limites NETTES (à l'emporte-pièce) ; IB = limites floues — l'inversion est piégée chaque année.
- **⚠** Néphroblastome (Wilms) = rénal ; Neuroblastome = surrénalien (biopsie contre-indiquée).
- **⚠** Image en trognon de pomme = cancer colique ; cocarde/cible = invagination ; arceau/grain de café = volvulus du sigmoïde.
- **⚠** Verre dépoli & micronodules à limites NETTES = interstitiel ; opacité confluyente systématisée à bronchogramme = alvéolaire.

**** SÉMIOLOGIE & ENCHAÎNEMENTS À MÉMORISER ****

- Densités scanner : graisse (négative) < eau (~0) < tissu < sang frais < calcium/os (très dense).
- Réaction périostée : continue/pleine = BÉNIN ; interrompue (Codman), plurilamellaire (bulbe d'oignon), spiculée (feu d'herbe) = MALIN.
- CHC typique : WASH-IN artériel → WASH-OUT portal (+ capsule).
- Localisation osseuse → diagnostic : épiphyse (chondroblastome, TCG) · métaphyse (ostéosarcome, ostéomyélite) · diaphyse (Ewing, histiocytose).
- Atélectasie → rétraction homolatérale ; effet de masse (épanchement, grosse tumeur) → refoulement controlatéral.
- Signe de la silhouette : effacement d'un bord = contact entre deux densités hydriques (localise l'opacité dans le plan antéro-postérieur).

Généré par Claude.ai (Claude Opus 4.8 (skill qe-analysis)) — Version 1
 Cross-match 700 QEs officielles × Cours AIO Radiologie (2163 p.) + 700 QE officielles e-qe.online
FMPM — Concours de Radiologie 2026 • Cross-match QE officielles × cours officiel

Améliorations Version 1 :

- ✓ Parser corrigé : 700 QE / 14 sessions (2018 → janv. 2026) — vs 100 capturées par le parser d'origine
- ✓ Faits ancrés sur les corrections officielles (option correcte = VRAI, option fausse = piège), pas sur la mémoire
- ✓ Déduplication des questions répétées + citations compactes par session
- ✓ FAUX explicites avec **⚠** (le contenu à plus haut rendement à l'examen)
- ✓ Session 2024 Exceptionnelle : énoncés sans corrigé officiel dans le fichier → non utilisée pour trancher VRAI/FAUX